

성인 Daily Day 08 - 고요산혈증/통풍

급성 관절염

ULT

KCD M10.x

작성일 2026-07-05

오늘의 목표

급성 통풍 발작에서 감염성 관절염을 놓치지 않고 NSAID, colchicine, steroid 중 안전한 약을 고른다. 재발성 통풍에서는 allopurinol을 낮게 시작해 요산 목표까지 증량한다.

1. 첫 3분 Triage

당일 의뢰: 발열/오한, 면역저하, prosthetic joint, 최근 관절주사/수술, 외상/골절 의심, 통풍 병력이 불확실한 심한 단관절염, 다관절+고열.

- 이전 통풍과 같은 양상인지, 감염/외상 단서가 있는지 먼저 확인한다.
- 신기능, GI bleeding, 심부전, 항응고제, 당뇨를 확인해 약을 고른다.
- ULT 적응증이 있으면 발작 조절과 장기 요산 관리 계획을 분리해 설명한다.

2. 핵심 문진/PE

문진 5개	Physical exam
반복 발작, 발열/외상/상처, CKD/GI/심부전/항응고제, 음주/탈수/과식, ULT 복용과 발진 병력	관절 열감/발적/종창, 상처/봉와직염, tophi, 체온/맥박, 다관절 침범

3. 검사

상황	검사	해석/행동
급성 발작	CBC/CRP 선택, Cr/eGFR, AST/ALT, uric acid	요산은 급성기에 정상일 수 있다.
감염 의심	관절천자/배양 의뢰	septic arthritis 가능하면 의뢰.
ULT 시작 전	uric acid, Cr/eGFR, AST/ALT, CBC	시작 용량과 추적 기준값.
증량 중	uric acid q2-5주, CBC/LFT/Cr	목표 <6 mg/dL까지 증량.

4. 급성기 처방

선택	예시	피해야 할 상황
NSAID	Naproxen 250-500 mg bid 등	eGFR 저하, GI bleeding, 항응고제, 심부전.
Colchicine	1.2 mg 후 1시간 뒤 0.6 mg	eGFR 저하, CYP3A4/P-gp inhibitor, 설사, 고령.
Steroid	Prednisolone 20-30 mg qd 3-5일	감염 배제 안 됨, 혈당 조절 매우 불량.
관절강내 steroid	1-2개 큰 관절	감염 가능성 있으면 금지.

5. ULT 시작 기준

시작 고려: 1년 2회 이상 발작, tophi, 영상상 손상, CKD stage 3 이상, 요로결석, uric acid >9 mg/dL. 증상 없는 고요산 혈증만으로는 보통 시작하지 않는다.

약제	시작/목표	주의
Allopurinol	100 mg qd 이하 시작, CKD면 더 낮게. 목표 uric acid <6.	발진 즉시 중단, 한국인 HLA-B*58:01 고려.
Febuxostat	40 mg qd 시작	심혈관질환 병력 신중.
Prophylaxis	colchicine 0.6 mg qd-bid 또는 NSAID 저용량	최소 3-6개월, 신기능/상호작용 조정.

6. Follow-up / Refer

- 급성기 3-7일 내 반응 확인. 발열/악화/다관절이면 재평가.
- ULT 시작 후 2-5주마다 요산 확인, 목표 도달까지 증량.
- 감염 감별, CKD 진행, 결석 반복, 약제 과민반응, tophi 기능장애는 의뢰.

7. 환자 설명 스크립트

- 통풍약은 급성기 염증을 끄는 약과 요산을 낮추는 장기약이 다릅니다.
- 요산수치는 발작 중 정상처럼 나올 수도 있어 오늘 수치 하나로 배제하지 않습니다.
- Allopurinol 시작 뒤 발진, 입안 혈음, 열이 나면 바로 중단하고 연락해야 합니다.

8. 자가체크

1. 급성 단관절염에서 먼저 배제해야 할 질환은?
2. NSAID를 피해야 할 상황은?
3. ULT 시작 적응증은?
4. Allopurinol 시작 용량과 목표 요산은?
5. flare prophylaxis를 쓰는 이유는?

참고 출처

ACR 2020 Gout Guideline: <https://rheumatology.org/gout-guideline>
FDA Colcrys label; FDA allopurinol label, HLA-B*58:01 warning.